

1. El paciente cuenta qué necesita

RESERVA ASISTIDA

Lenguaje simple, sin conocer la estructura del hospital

- Motivo y señales de alarma.
- Zona y evolución cuando corresponde.
- Servicio sugerido por reglas clínicas declarativas.
- Reserva desde conversación o pantalla directa.
- Consulta por mensaje y seguimiento de tratamiento en un flujo dedicado.

No diagnostica: organiza el acceso y protege el circuito.

Bioendace - Demo comercial · Turnos

Necesito atención por un dolor que empezó ayer.

Antes de buscar un turno, necesito hacerte unas preguntas breves.

¿Apareció alguna señal de alarma?

¿En qué zona sentís el dolor?

2. Seguridad antes de disponibilidad

Banda A

Alarma actual

La app detiene la reserva y orienta al circuito de urgencia / 107.

B-D

Atención programable

Continúa según prioridad, servicio, política local y modalidad permitida.

La disponibilidad nunca debe imponerse sobre una señal clínica de alarma.

IMPLEMENTADO

Catálogo versionado, persistencia del recorrido y validación al crear el turno.

3. La modalidad se ofrece cuando corresponde

Presencial

Camino base para atención ambulatoria programable.

Videollamada con turno

Solo si lo permiten el motivo, el servicio y la agenda profesional.

Consulta por mensaje

Atención asincrónica sin turno ni video; responde un profesional real.

Si solo aplica presencial, Bioenlace omite el paso de modalidad: menos decisiones innecesarias.

GOBERNADO Política por servicio + elegibilidad de triage + agenda que acepta remoto. Especialistas con derivación vigente del clínico.

4. Agenda operativa para cada actor

Paciente y representante

- Reservar, cancelar y reprogramar.
- Gestionar a un menor o adulto que delegó.
- Recibir avisos y resolver cambios desde la app.

Profesional y efector

- Grilla, cupos, sobretornos y agenda del día.
- Alta para terceros y cancelación masiva.
- Políticas locales con permisos por rol y recurso.

Ambulatorio usa cupos y turnos. Guardia e internación usan cobertura de personal: Bioenlace no fuerza la misma agenda para procesos diferentes.

5. El turno prepara la consulta

Al reservar

Se conserva triage, servicio, modalidad y contexto de agenda.

Ventana previa

El paciente completa intake, motivos conversacionales y asistencia preconsulta cuando aplica.

Al abrir la historia

El equipo ve preguntas previas, resumen de motivos e información de cohorte.

Después

Touchpoints de seguimiento y acceso a planes de tratamiento.

Menos tiempo reconstruyendo el motivo. Más tiempo para la decisión clínica.

6. Cuando cambia la agenda, el turno entra “en resolución”

Opciones concretas

Bioenlace puede adjuntar hasta tres horarios vecinos y compatibles en el aviso.

Escalada

Aviso en la app y, si no hay respuesta, email y SMS con enlace seguro.

Preferencias

Si el paciente lo autorizó, puede reubicarse automáticamente cuando hay una alternativa inequívoca.

IMPLEMENTADO V1 Reubicación, opciones alternativas, escalada multicanal y auditoría. **CONFIGURABLE** Reubicación automática por paciente y efector. Tras 72 h sin respuesta: cierre con cancelación o escalada a staff según reglas.

7. Un cupo cancelado puede volver a utilizarse



IMPLEMENTADO Agente de reglas A03; el perfil histórico no excluye ni ordena candidatos.

8. Medir acceso sin planillas

Inasistencias

Ausencias atribuibles al paciente sobre turnos cerrados.

Tiempo hasta la cita

Días entre reserva y consulta: promedio y mediana.

Remoto

Demanda presencial que podría resolverse con otra modalidad.

**La dirección consulta indicadores desde Bioenlace, con filtros por período y recurso.
Recordatorios y confirmación proactiva antes de liberar cupos en casos de alto riesgo.**

Transparencia antes que un “score” opaco

Perfil factual

- Hechos atribuibles y versionados.
- Asistencia, cancelación, reprogramación y confirmación.
- Explicación y solicitud de corrección.

Límites explícitos

- No es reputación ni prioridad clínica.
- Datos insuficientes no significan riesgo.
- No se liberan cupos automáticamente durante shadow.

SHADOW / PILOTO PENDIENTE

La infraestructura de transparencia existe; las acciones de alto impacto requieren evidencia, equidad, aprobación y rollback.

Qué obtiene cada organización

Paciente

Menos llamadas, orientación clara, autogestión y continuidad desde el celular.

Equipo de salud

Agenda conectada con contexto clínico, menos tareas repetitivas y decisiones confirmables.

Dirección / red

Políticas por efector, trazabilidad, indicadores e interoperabilidad vía API/FHIR.

Bioenlace no agrega otro canal: conecta los canales alrededor del mismo turno y del mismo encounter.

Quion de demo en vivo

1

Paciente: iniciar "Necesito atención" y recorrer motivo + triage.

2

Reserva: mostrar cuándo aparece modalidad, elegir centro y horario.

3

Preparación: abrir el journey y cargar motivos previos.

4

Personal: abrir la historia con contexto y simular captura clínica.

5

Operación: mostrar reprogramación, opciones de reubicación u oferta de adelantamiento.

Implementación gradual, valor desde la primera etapa

1

Agenda y autogestión

Reserva, avisos, cancelación y reprogramación.

2

Journey clínico

Triage, motivos, preconsulta, captura y seguimiento.

3

Optimización

Resolución, reocupación, indicadores y agentes auditables.

Licencia por profesionales y clase de atención; módulos y políticas se habilitan según alcance del efector.

Un turno puede ser el inicio de una atención mejor conectada

Orientar, reservar, preparar, atender y seguir — en un único ecosistema, con reglas claras y control humano.

bioenlace.io · info@bioenlace.io